

CoWell ステークホルダー分析 まとめ

帝京大学 西村さんから提供された Stakeholder Analysis Guidelines (USAID/PHR, Kammi Schmeer 1999) を、CoWell の文脈に落とし込んだ作業メモです。論文の Discussion 章および推進メンバー教材のたたき台。

1. なぜこの分析が論文に必要なか

CoWell の本質は「健康と言わずに健康関心を芽生えさせる迂回路アプリ」。ここに辿り着いた経緯は、経営者として 30 年現場を見てきた暗黙知 (=「強制では運送業の人は動かない」「指示の瞬間に冷める」) が原点で、これまで論文向けに体系化されていませんでした。

Stakeholder Analysis は、その暗黙知を「誰がどの立場で・どれだけ力を持ち・どう動かすか」という整った言語に翻訳できる枠組みです。介入研究 (CoWell 使用前後の関心度・行動変容) を主軸にした上で、「なぜこの介入が運送業で機能したのか」という実装文脈を Discussion で語る道具として最適。

2. ステークホルダー分析とは (3行で)

- 1. 政策・施策に利害を持つ「全主体 (ステークホルダー)」をリスト化する
- 2. 各人の 知識・立場 (賛否)・利害・同盟・権力・リーダーシップ を表に整理する
- 3. 「誰を維持/強化/転換/中立化/抱き込む」かの 5 戦略目標 を立て、限られたリソースで動かす

立場の5段階 (左ほど支持):

S (強支持) – MS (穏健支持) – N (中立) – MO (穏健反対) – O (強反対)

権力指数 (1~3) = 資源量 (多/中/少) × 動員能力 (単独決裁/合議/権限なし) の平均。リーダーシップは Yes/No (= 行動を起こす意思があるか)。

3. CoWell の Position Map (現状想定)

縦軸 = CoWell 中核 (経営者・推進メンバー) からの距離。横軸 = CoWell への立場。色の濃さ (太字) = 影響力の高さ。

セクター ¥ 立場	S (強支持)	MS (穏健支持)	N (中立)	MO (穏健反対)	O (反対)
政策原点 経営者・推進	小林 / 立石 / 吉沢				

セクター ¥ 立場	S (強支持)	MS (穏健支持)	N (中立)	MO (穏健反対)	O (反対)
内側近接 管理職・運管		一部の運管	中間管理職多数	業務負荷を嫌う管理職	
内側遠 現場ドライバー		健康自覚あり層	若手・中堅多数	自覚なし高血圧層	強い拒否層
準内側 家族・配偶者		配偶者の一部			
専門家 産業医・保健師	保健師 (関与時)	福田 / 西村	産業医 (年1接点)		
外部支援 NPO・大学	NPO 推進派	NPO 観望組			

この図から見える論点

- 核心の壁は「内側遠 × N～MO」のセル (= 運送業現場のマス層)
- 経営者・推進メンバー・大学・NPO は最初から S～MS で並んでおり、「上から下へ届かない」構造が明確
- O (強反対) は数は少ないが、N の集団に影響を伝染させる
- 家族・配偶者という 準内側の MS が、論文の novel 主張になり得る (会社経由でなく家族経由で届ける可能性)

4. 5つの戦略目標 × CoWell の具体施策

戦略 1. 支持者を維持する

対象: 経営者・推進メンバー・福田/西村・NPO推進派

- 経営ダッシュボードに「気づき件数 / アクションプラン作成数 / 共有水槽稼働率」を直結
- 推進メンバーへ毎週の小さな成功体験 (現場の声 POST → 採用 → 完了アナウンス)
- 福田/西村へは四半期1本の定例レポートで学術的後ろ盾を切らさない
- NPO 推進派には四半期1本のケーススタディ提供

戦略 2. 支持者の権力・リーダーシップを増強する

対象: 推進メンバー (立石・吉沢)

- 「健康戦略室マスター」の役割を組織図上で可視化
- g_field_voice チャットでの発言を AI が要約 → 施策化導線で 現場を引き寄せた数 = リーダーシップ実績 として蓄積
- NPO 160 社経由で「外部成功事例ホルダー」のステータス獲得 (社内向けに逆輸入)

戦略 3. 反対者を支持者へ転換する (CoWell のキモ)

対象: 中間管理職 (MO) / 自覚なし高血圧ドライバー (MO) / 強い拒否層 (O)

- **中間管理職 (MO) → MS:**「部下の体調管理コストを下げるツール」として再ポジション。役員 POST から現場への直接介入を奨励せず、管理職の負担を増やさない設計を貫く。
- **自覚なし高血圧ドライバー (MO) → N → MS:** **直接アプローチを禁止**。海の冒険 / ペット / 共有水槽 / バディー の「健康と言わない迂回路」で N 側にスライド → 仲間経由・家族経由で MS へ。
- **強い拒否層 (O) → 静観:** 個別説得は行わず、MS 周辺の集団変化が滲み出すのを待つ (社会伝染戦略)。

戦略 4. 反対者の権力を弱める

対象: 反対派の正当性そのもの

- **トップダウン強制を禁忌として明文化**。「管理職経由の業務指示化」が反対者の最大の武器になるため、これを構造的に断つ。
- 経営哲学「受け身 → 自発」がそのまま戦略4の実装になっている。CoWell は最初から、強制すると反対者を勢いづかせる仕組みを排除している。

戦略 5. 中立を能動的支持者へ転換する (最大ボリューム)

対象: 「興味はあるが行動しない」N 層 (=現場ドライバーのマス)

フックは AIDA モデルの **A (Attention / Interest)** に全力集中:

- 入口カード 5枚 × 6〜7サブ (白い画面の撲滅)
- ヘルスバディーのカスタムアバター + 5性格
- 共有水槽デモ魚 / 卵 / 装飾ガチャ (アクアゾーン)
- 推進カフェ → 健康戦略室の社内可視化
- 「ごはん」表現・ニックネーム公開オプション (心理的安全)

→ どれも「健康」を口に出さずに開かせる迂回路。

5. 経営者経験との接続 (この分析の最大の発見)

CoWell の設計思想を Stakeholder Analysis の語彙で並べ直すと、以下が一致します:

経営者の暗黙知	Stakeholder Analysis の概念
「強制すると冷める」	戦略 4. 反対者の権力 (=強制への正当な抗議) を弱める
「健康と言うと離脱する」	戦略 5. 中立を AIDA-A 経由で転換する
「真面目な人だけが損する」	開示の罟 (= MO 層の保身行動) を回避する設計
「家族から響く」	準内側 MS (配偶者) を活用するルート
「現場の人を主役にしないと続かない」	戦略 2. 推進メンバーのリーダーシップ強化

= CoWell は、Stakeholder Analysis の処方箋を経営者経験から逆算的に実装していた。これが論文の Innovation 主張 (=「ボトムアップ介入の実装パターン」) として最も強い言い方になります。

6. 論文での使い方 (推奨配分)

主軸はあくまで 介入研究 (COM-B / ナッジ理論 × CoWell 使用前後の関心度・行動変容)。Stakeholder Analysis は次の場所で使う:

- **Implementation 章 (1段落):**「実装文脈として 6セクター × 5立場でステークホルダーを整理した」
- **Figure A:** CoWell Position Map (上の表)
- **Figure B:** 5戦略目標 × CoWell 施策のマッピング表
- **Discussion (1段落):**「経営者由来の暗黙知が Stakeholder Analysis の体系で再言語化された」という meta 視点

→ 介入効果の主軸を曇らせず、普及・スケール化の文脈整理として補助的に置くのがバランス。

7. 次に詰めるべき論点

論文の解像度を上げるため、福田さん・西村さんと早めに合意しておきたいポイント:

1. **Position Map の縦軸 (セクター粒度)** 家族・配偶者を入れるか? 産業医と保健師を分けるか? NPO を内 vs 外で分けるか?
2. **N (中立) 層の細分化**「健康自覚ゼロ / 漠然と不安 / 改善意欲あり停滞」の3層に割るか? 介入感度はそれぞれ違うはず。
3. **権力指数の日本版アレンジ** 原典は組織内決裁権ベースだが、CoWell では「行動変容ハードル」= 個人の COM-B 要素 (能力・機会・動機) で測る方がフィットする。
4. **戦略 3 の「家族経由ルート」** 現状 CoWell に家族向けインターフェースは無い。論文化するなら今後の研究課題として明記するか、Phase 2 として実装に着手するかの判断。
5. **倫理面**「無関心層を本人の自覚なしに動かす」設計は、ナッジ倫理の議論 (Sunstein のリバタリアン・パターナリズム) と接続する必要がある。

参考文献

- Schmeer, K. (1999). *Stakeholder Analysis Guidelines*, Section 2 of Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform. Partnerships for Health Reform, Abt Associates / USAID.
- Reich, M. R. (1993). Political Mapping of Health Policy. Harvard School of Public Health.
- 福田吉治 (2024). 健康無関心層へのアプローチ — COM-B モデルとナッジ介入の現状.

作成: 2026-05-07 **目的:** 論文ドラフト用の作業メモ / 推進メンバー (立石・吉沢) との議論用 **次のアクション:** 西村さんと Position Map の縦軸合意 → Figure A の確定